

毎日タダラフィルで、 老化は防げる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

承認された使い道との距離を軸に。

一般向け ／ 脳神経内科医 今村久司

毎日少量のタダラフィルは、老化を防ぐのか。

健康な中高年が、老化予防目的で
毎日飲むことの根拠は？

医師の判定

老化予防目的の毎日少量は「まだ分からない」。
承認された病気の治療とは、分けて考える。

ことば・研究・害と採点の順に見ます。

1

ことばと承認

国が認めた使い道確かめる。

2

研究の読み方

観察研究・認知症・検査値。

3

害・入手・採点

向かない人と、手に入れ方。

ことばの説明①

タダラフィル

PDE5阻害薬の一つ

血管などの筋肉をゆるめる薬。
国内ではEDや前立腺肥大症などに使う。

PDE5阻害薬

「血管をゆるめる体の合図」が、
長く続くようにする薬のグループ。

ことばの説明②

承認

しょうにん

国が、病気と量と飲み方を
確かめて認めた、薬の使い道。

適応外使用

てきおうがいしょう

承認された使い道の外で、
薬を使うこと。

ことばの説明③

ランダム化比較試験

くじ引きで組を分ける試験

飲む組と偽薬の組に分けて、結果を比べる。
薬の効果を、いちばん確かめやすい。

観察研究と交絡

飲む人と飲まない人を、後から比べる研究。
薬以外の違いが結果に混ざること＝交絡。

毎日飲む承認は、病気の治療だけ。

使い道	量・飲み方	毎日飲む承認
ED	約1時間前に10mg	なし（1日1回まで）
前立腺肥大症	毎日1回5mg	あり
肺の血管の病気	毎日1回40mg	あり
老化・若返り	承認の効能にない	なし

米国ではEDにも毎日少量の承認がある。日本のED用にはない。

ED薬を使う男性は、死亡が少ないという関連。

心筋梗塞のあとの男性などで、ED薬の人に死亡が少ない。

ED薬を処方される人は、もともと元気な人が多い。

著者自身が、交絡の可能性を認めている。

ここが大切

頓用と書かれた研究もあり、毎日少量の研究ではない。

「飲めば死亡が減る」とは読めない。

同じタダラフィルでも、条件が違う。

観点	観察研究	知りたいこと
飲み方	頓用か、書かれていない	毎日少量
飲む人	ED・心臓病などの男性	健康な中高年
比べ方	後から比べる	くじ引きで組を分ける
結果	関連（交絡が残る）	老化や死亡が減るか

処方される人は、もともと元気な人が多い。

結果は割れている。連日少量の解析は差なし。

解析	対象	結果
シルデナフィル	米国の保険のデータ	タダラフィルは出てこない
英国のED男性	ED薬を始めた人	3年後からは差と言えない
連日少量の解析	前立腺肥大症の人	別の薬と比べ差なし
遺伝子を使う解析	4つのデータ	因果の関連は見られず

少ないとする解析もあるが、質は非常に低いと著者。

良くなった試験と、差がない試験がある。

試験	対象・量	結果
ある宣伝の根拠	32名・4週・1日おき20mg	内皮機能が改善
偽薬対照の試験	ED男性215名・毎日5mg	内皮の指標に差なし
前立腺肥大症	比べる組なし・5mg	動脈の硬さなどが改善
まとめた解析	PDE5阻害薬全体	心血管病の人で改善

検査値が良くなっても、病気や老化が減るとは限らない。

ヒトの比較試験は、見つからなかった。

老化の目印や寿命を見た比較試験：見つからず。

健康な人の死亡・病気の比較試験：見つからず。

登録サイトで老化などに当たったのは、取り下げの1件。

ここが大切

マウスの良い結果は、ヒトでの効果を示さない。

検査値だけの改善は、採点の①に入れない。

「毎日の少量なら安全」とは言えない。

多い副作用：頭痛・顔の赤み・消化不良・背中や筋肉の痛み。

毎日飲むと、体の中の量は初日より多くなる。

毎日使った長期の試験は、病気のある人の1～2年のもの。

ここが大切

健康な人が老化予防目的で長く飲んだデータはない。

連日で害がどう変わるかも、分かっていない。

併用しない・すぐ受診する、4つのこと。

- 狭心症の薬と一緒に使う

硝酸薬との併用は禁忌。血圧が下がりすぎる。

- 急に片目の視力が落ちる

NAION。まれで、増えるかは研究で割れている。

- 急に聞こえが悪くなる

突発性難聴。頻度は不明。耳鼻科へ。

- 勃起が4時間以上続く

持続勃起。すぐに受診が必要。

毎日少量の研究は見つからず。定期使用で約2倍の報告あり。

当てはまる人は、自己判断で飲まない。

- ✓ 狭心症の薬（硝酸薬）を使っている
- ✓ 心臓の病気や、最近の心筋梗塞・脳卒中がある
- ✓ 血圧の薬や前立腺の薬を飲んでいる
- ✓ 一部の抗菌薬・抗真菌薬を飲んでいる

グレープフルーツジュースでも、薬が効きすぎることもある。

「処方が必要」は、医療用の話。

入手の道	必要なこと	注意
医療用	医師の処方箋	保険は承認の病気だけ
老化予防の処方	自費（保険の対象外）	適応外・価格の出典なし
ED用の市販薬	2026年～・薬剤師の確認	毎日飲む用法ではない
個人輸入・ネット	国の品質の確認なし	偽造品・救済制度の対象外

厚生労働省の調査では、個人輸入のED薬10製品のうち4製品が偽造品。

老化予防目的の毎日少量は、根拠C。

物差し	老化予防目的の毎日少量	理由
①根拠の強さ	C	観察研究と小規模試験
②効果の大きさ	なし・不明	健康な人で未確認
③安全性	中	まれな重い害・長期は患者
④費用・手間	出典なし	自費の価格の公的資料なし

検査値だけの改善は①に入れない。承認された病気の治療は採点の外。

飲む前に、3つのこと。

1 自己判断しない

老化予防に、

自己判断や個人輸入で
飲まない。

2 症状は医療機関へ

EDや排尿の症状

承認された使い道で、
医療機関で相談。

3 土台から始める

土台は、

第2回の筋トレ、
第7回の地中海食へ。

薬を飲んでいる人は、特に自己判断で飲まない。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

承認された使い道と、
老化予防は別に読む。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

薬を飲んでいる人は、
自己判断で飲まない。

個々の治療は担当医と相談。